强制诱导言语治疗结合音乐疗法对脑卒中后失语症患者语言交流能力的影响观察

李世美　曹全荣　林晓云　李志斌　唐辉玲　叶锦萍

【摘要】 **目的**　观察强制诱导言语治疗结合音乐疗法对脑卒中后失语症患者语言交流能力的影响。**方法**　60 例脑卒中后失语症患者，随机分为对照组、观察组，每组 30 例。两组患者均给予常规的言语治疗，对照组给予强制诱导言语治疗，观察组给予强制诱导言语治疗结合音乐疗法。比较两组治疗前后中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表 (CRRCAE)、日常生活交流能力检查量表 (CADL) 评分。**结果**　治疗 4 周后，观察组名词理解、动词理解、句子理解、复述名词、复述动词、复述句子、说名词、动作说明、画面说明、出声读名词、出声读动词、出声读句子、阅读名词、阅读动词、阅读句子评分分别为 (7.26 ± 1.448)、(6.36 ± 1.684)、(3.50 ± 2.192)、(8.70 ± 1.830)、(8.36 ± 1.720)、(2.66 ± 1.066)、(5.60 ± 2.811)、(4.83 ± 2.074)、(3.33 ± 1.874)、(5.90 ± 2.155)、(4.93 ± 1.512)、(1.23 ± 1.344)、(6.96 ± 1.772)、(6.10 ± 1.951)、(3.26 ± 1.473) 分，高于对照组的 (6.30 ± 1.654)、(5.40 ± 1.847)、(2.13 ± 2.885)、(7.73 ± 1.664)、(7.33 ± 1.974)、(1.73 ± 1.448)、(4.23 ± 2.013)、(3.60 ± 2.058)、(2.33 ± 1.470)、(4.63 ± 2.605)、(3.76 ± 1.370)、(0.56 ± 0.887)、(5.63 ± 1.624)、(4.80 ± 1.604)、(2.16 ± 2.097) 分，差异有显著性意义 (P<0.05)。治疗 4 周后，观察组患者 CADL 评分 (40.83 ± 13.001) 分高于对照组的 (32.86 ± 14.591) 分，差异有显著性意义 (P<0.05)。**结论**　强制诱导语言治疗结合音乐疗法能有效提高脑卒中后失语症患者的语言交流能力。

【关键词】 强制诱导言语治疗；音乐疗法；脑卒中后失语症；语言交流能力

DOI：10.14163/j.cnki.11-5547/r.2025.04.045

Observation on effect of post-stroke aphasia patients by combining constraint-induced aphasia therapy with music therapy

LI Shi-mei, CAO Quan-rong, LIN Xiao-yun, et al. Department of Rehabilitation Therapy, Jiangmen Rehabilitation Hospital, Jiangmen 529000, China

【**Abstract**】 **Objective**　To observe the effect of post-stroke aphasia patients by combining constraint-induced aphasia therapy with music therapy. **Methods**　60 patients with post-stroke aphasia were randomly divided into control group and observation group, each with 30 cases. Both groups were given routine speech therapy. The control group was treated with constraint-induced aphasia therapy, and the observation group was treated with constraint-induced aphasia therapy in combination with music therapy. The Chinese Rehabilitation Research Center Standard Aphasia Examination (CRRCAE) and Communication Abilities of Daily Living (CADL) scores before and after treatment were compared between the two groups. **Results**　After 4 weeks of treatment, the scores of noun comprehension, verb comprehension, sentence comprehension, noun paraphrasing, verb paraphrasing, sentence paraphrasing, noun speaking, action description, visual description, reading nouns aloud, reading verbs aloud, reading sentences aloud, reading nouns, reading verbs, and reading sentences were (7.26 ± 1.448), (6.36 ± 1.684), (3.50 ± 2.192), (8.70 ± 1.830), (8.36 ± 1.720), (2.66 ± 1.066), (5.60 ± 2.811), (4.83 ± 2.074), (3.33 ± 1.874), (5.90 ± 2.155), (4.93 ± 1.512), (1.23 ± 1.344), (6.96 ± 1.772), (6.10 ± 1.951), and (3.26 ± 1.473) points, which were higher than (6.30 ± 1.654), (5.40 ± 1.847), (2.13 ± 2.885), (7.73 ± 1.664), (7.33 ± 1.974), (1.73 ± 1.448), (4.23 ± 2.013), (3.60 ± 2.058) (2.33 ± 1.470), (4.63 ± 2.605), (3.76 ± 1.370), (0.56 ± 0.887), (5.63 ± 1.624), (4.80 ± 1.604), and (2.16 ± 2.097) points in the control group, and the difference was statistically significant (P<0.05). After 4 weeks of treatment, the observation group had higher CADL score of (40.83 ± 13.001) points than (32.86 ± 14.591) points in the control group, and the difference was significant (P<0.05). **Conclusion**　The combination of constraint-induced aphasia therapy and music therapy can effectively improve language communication ability of patients with post-stroke aphasia.

【**Key words**】 Constraint-induced aphasia therapy; Music therapy; Post-stroke aphasia; Language communication ability

---

基金项目：江门市卫生健康系统科研立项项目 (项目编号：21A029)

作者单位：529000　江门市康复医院康复治疗科

中国知网　https://www.cnki.net

脑卒中是高死亡率和致残率的全球性疾病，严重威胁患者的健康和生活质量，失语症是脑卒中常见并发症之一[1-3]。常规的言语康复训练对失语症虽有一定效果，但因显效缓慢、形式单调等，易使患者产生缺乏信心，抵触心理，从而影响治疗效果及产生不良情绪等。为探讨更好的治疗方法，本研究运用强制诱导言语治疗 (constraint-induced aphasia therapy, CIAT) 结合音乐疗法治疗，分析其对脑卒中后失语症患者语言交流能力的影响，以探索更为高效的临床治疗方案。报告如下。

1　资料与方法

1.1　一般资料　选取 2021 年 4 月 ~2023 年 3 月在本院治疗的脑卒中后失语症患者 60 例，随机分为对照组与观察组，各 30 例。两组患者一般资料无显著性差异 (P>0.05)，可比。见表 1。

表 1　两组患者一般资料比较 (n, $\bar{x} \pm s$)

组别	例数	性别		年龄 (岁)	受教育时间 (年)	病程 (个月)	卒中类型	
		男	女				脑梗死	脑出血
观察组	30	12	18	59.60 ± 12.21	9.20 ± 2.72	3.93 ± 2.22	17	13
对照组	30	14	16	61.46 ± 13.89	8.90 ± 2.89	4.12 ± 3.00	16	14
χ^2/t		0.271		0.551	0.414	0.279	0.067	
P		0.602		0.583	0.680	0.781	0.795	

注：两组比较，P>0.05

1.2　纳入及排除标准

1.2.1　纳入标准　①符合脑卒中诊断标准[4]；②经头颅 CT 或磁共振成像 (MRI) 证实为脑卒中；③经 CRRCAE 诊断为失语症。

1.2.2　排除标准　①患者合并严重器官性疾病；②患者存在精神或意识障碍；③患者并发严重视力、听力障碍。

1.3　治疗方法　两组患者均给予常规营养神经类药物、运动治疗、物理因子治疗、作业治疗、中医治疗、常规言语治疗。常规言语治疗包括听理解、复述、口语表达、阅读和书写训练等，根据患者“听、说、读、写”4 个方面障碍程度的不同选择不同的训练方式[5]。

1.3.1　对照组　给予强制诱导言语治疗，其为强调以言语诱导、小组游戏和群体交流为核心的训练方式，通过参与丰富多彩的小组游戏和群体交流活动，患者不仅能够在轻松愉快的氛围中学习新的言语表达技巧，还能在与他人的互动中逐渐找回自信，提升社交能力。在治疗过程中，特别要求患者运用已掌握或易于说出的词语进行交流，在交流过程中避免患者过度依赖手势和其他身体语言。同时，将日常生活相关的内容作为训练的重点，让患者能够在熟悉的场景中更自然地运用所学到的言语技巧，短期高强度集中训练，在治疗室集中训练 30 min/ 次，1 次 /d, 共训练 4 周。

1.3.2　观察组　在强制诱导言语治疗基础上结合音乐疗法：根据患者的背景资料 (如日常用语、文化程度、兴趣爱好、性格等) 选择其熟悉的歌曲演唱。①对于部分完全性失语但韵律功能保留较好的患者：运用旋律语调法 (Melodic Intonation Therapy, MIT), 从日常用语→哼唱出来→复述、命名训练。②对于不会唱歌的患者：从听音乐、哼曲调→跟唱→歌词复述→命名训练；③对于可以跟唱歌曲的患者：从跟唱→歌词复述→歌词中人、事、物命名训练。在治疗室集中训练 30 min/ 次，1 次 /d, 共训练 4 周。

1.4　观察指标及判定标准　①语言功能：采用 CRRCAE 评定患者治疗前后的语言功能，包括名词理解、动词理解、句子理解、复述名词、复述动词、复述句子、说名词、动作说明、画面说明、出声读名词、出声读动词、出声读句子、阅读名词、阅读动词、阅读句子 15 项，分数越高语言功能越好[6]；②交流能力：采用日常生活交流能力检查 (communicative abilities in daily living, CADL) 评估[7]，主要包括 22 项 (34 个亚项) 日常生活的交流活动，分数越高交流能力越好。

1.5　统计学方法　用 SPSS17.0 统计软件行统计分析。以率 (%) 表示计数资料，采用 χ^2 检验；以均数 ± 标准差 ($\bar{x} \pm s$) 表示计量资料，采用 t 检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　整体治疗情况　两组患者均未出现严重不良反应、严重并发症等，均无脱落病例。

2.2　两组患者治疗前 CRRCAE 评分比较　治疗前，两组名词理解、动词理解、句子理解、复述名词、复述动词、复述句子、说名词、动作说明、画面说明、出声读名词、出声读动词、出声读句子、阅读名词、阅读动词、阅读句子评分比较无显著性差异 (P>0.05)。见表 2。治疗 4 周后，观察组名词理解、动词理解、句子理解、复述名词、复述动词、复述句子、说名词、动作说明、画面说明、出声读名词、出声读动词、出声读句子、阅读名词、阅读动词、阅读句子评分高于对照组，差异有显著性意义 (P<0.05)。见表 3。

2.3　两组患者治疗前后 CADL 评分比较　治疗前，两组患者 CADL 评分比较无显著性差异 (P>0.05)；治疗 4 周后，观察组患者 CADL 评分高于对照组，差异有显著性意义 (P<0.05)。见表 4。

中国知网　https://www.cnki.net

表 2　两组患者治疗前 CRRCAE 评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

项目	对照组 (n=30)	观察组 (n=30)	t	P
名词理解	4.60 ± 3.233	5.76 ± 3.287	−1.378	0.178
动词理解	3.66 ± 3.304	4.50 ± 3.401	−0.970	0.336
句子理解	1.56 ± 2.712	2.60 ± 3.222	−1.353	0.181
复述名词	6.16 ± 3.374	6.40 ± 3.265	−0.280	0.780
复述动词	5.96 ± 3.718	6.03 ± 3.605	−0.074	0.941
复述句子	1.03 ± 1.973	1.63 ± 2.999	−0.915	0.364
说名词	2.73 ± 3.300	3.70 ± 3.465	−1.110	0.271
动作说明	0.43 ± 1.546	0.66 ± 1.667	−0.554	0.582
画面说明	1.70 ± 1.271	1.60 ± 1.080	−0.328	0.744
出声读名词	3.26 ± 3.703	4.10 ± 3.754	−0.873	0.387
出声读动词	2.83 ± 3.434	3.73 ± 3.590	−0.992	0.325
出声读句子	0.43 ± 1.851	0.70 ± 1.967	−0.548	0.586
阅读名词	4.50 ± 3.785	5.63 ± 3.498	−1.201	0.235
阅读动词	3.66 ± 3.808	4.40 ± 3.909	−0.743	0.461
阅读句子	1.63 ± 2.965	2.40 ± 3.358	−0.941	0.350

注：两组比较，$P>0.05$

表 3　两组患者治疗 4 周后 CRRCAE 评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

项目	对照组 (n=30)	观察组 (n=30)	t	P
名词理解	6.30 ± 1.654	7.26 ± 1.448[a]	−2.392	0.020
动词理解	5.40 ± 1.847	6.36 ± 1.684[a]	−2.104	0.040
句子理解	2.13 ± 2.885	3.50 ± 2.192[a]	−2.071	0.043
复述名词	7.73 ± 1.664	8.70 ± 1.830[a]	−2.148	0.036
复述动词	7.33 ± 1.974	8.36 ± 1.720[a]	−2.155	0.035
复述句子	1.73 ± 1.448	2.66 ± 1.066[a]	−2.833	0.006
说名词	4.23 ± 2.013	5.60 ± 2.811[a]	−2.170	0.034
动作说明	3.60 ± 2.058	4.83 ± 2.074[a]	−2.306	0.025
画面说明	2.33 ± 1.470	3.33 ± 1.874[a]	−2.230	0.025
出声读名词	4.63 ± 2.605	5.90 ± 2.155[a]	−2.058	0.044
出声读动词	3.76 ± 1.370	4.93 ± 1.512[a]	−3.141	0.003
出声读句子	0.56 ± 0.887	1.23 ± 1.344[a]	−2.279	0.026
阅读名词	5.63 ± 1.624	6.96 ± 1.772[a]	−3.031	0.004
阅读动词	4.80 ± 1.604	6.10 ± 1.951[a]	−2.819	0.007
阅读句子	2.16 ± 2.097	3.26 ± 1.473[a]	−2.351	0.022

注：与对照组比较，[a]$P<0.05$

表 4　两组患者治疗前后 CADL 评分比较 ($\bar{x} \pm s$, 分)

组别	例数	治疗前	治疗 4 周后
对照组	30	26.66 ± 16.001	32.86 ± 14.591
观察组	30	21.36 ± 15.085	40.83 ± 13.001[a]
t		1.320	−2.234
P		0.192	0.029

注：与对照组治疗 4 周后比较，[a]$P<0.05$

中国知网　https://www.cnki.net

3　讨论

脑卒中后导致的失语症常影响患者的语言交流能力，致使患者与他人无法进行有效沟通，继而导致患者对生活失去信心，影响其生活质量。强制诱导言语治疗是基于强制诱导运动疗法发展并应用于言语治疗，患者在高强度、治疗性交流环境中进行系统化言语学习，通过短时间的强制诱导言语治疗，提高患者语言的词汇量及应用能力，从而提高其语言交流能力，促进其主动交流，参与社会活动[8]。其遵循以下原则：首先，集中训练原则是基于神经可塑性理论，即在短时间内集中进行高强度的训练可以更有效地促进大脑相关功能区的重组和恢复。因此，对于失语症患者来说，短期高强度的集中言语训练可以更有效地提高患者的语言能力[9]。其次，强制性诱导原则强调在治疗过程中，治疗师需要积极地引导和强制患者使用语言进行交流，而不是依赖手势或其他非语言交流方式。这有助于患者重新建立对语言的依赖和信心，促进患者主动使用语言进行交流。最后，生活相关原则是为了确保患者在治疗过程中所学到的语言知识能够应用到日常生活中。通过与日常生活紧密相关的内容进行训练，可以提高患者的兴趣和参与度，同时也更容易理解和记忆[10]。这些原则的目的是为了最大化提高患者的治疗效果，使患者能够尽快地恢复正常的语言交流能力。

从神经生理学的角度看，强制诱导言语治疗的作用机制可能涉及多个复杂的过程。这些过程不仅涉及患者大脑语言处理区的重新激活和强化，也可能涉及整个大脑半球之间的重新平衡和整合。患者接受该治疗后，左侧额下回的激活增强，这可能表明治疗有助于恢复或优化这一关键语言处理区域的功能。同时，右侧额下回的激活减弱，则可能表明治疗在某种程度上调整了大脑两半球在语言处理上的分工和协作。此外，强制诱导言语治疗可能还促进了双侧额叶、颞叶等多个脑区的重组，形成了一个更为高效和协调的语言功能网络。这种重组可能使得语言信息在大脑中能够更好地传递和处理，从而改善患者的语言功能[11]。值得注意的是，这种重组并非简单的激活或调节特定脑区，而是通过一系列复杂的过程，包括神经网络的重塑和优化等，实现大脑的整体康复[12]。根据失语症治疗的主要目的，强制诱导言语治疗的目的并非仅仅在于激活或调节特定的脑区，而是要通过平衡训练使损伤半球的语言处理能力得到恢复和提升。这种平衡训练可能包括对两侧大脑半球的训练，以及对多个脑区的协同训练，从而实现整个语言处理网络的优化和升级[13]。

音乐疗法是一种独特而有效的跨学科治疗方法，其结合了心理学、美学以及康复医学等多学科的理论。其核心在于利用音乐的节奏感和旋律性，提升患者对声音的感知能力。通过参与唱歌、乐器演奏或聆听音乐等活动，进一步促进患者语言能力的恢复[14-16]。音乐疗法主要作用于大脑皮层右侧颞叶的音乐活动中枢，通过对下丘脑和脑干网状结构、边缘系统、副交感神经系统等产生刺激，影响人体感知觉、运动觉、情绪情感，从而达到恢复语言功能的目的。研究表明，这种疗法在治疗多种语言和表达障碍方面均显示出显著的效果，为患者带来了新的康复希望[17,18]。

研究表明，治疗4周后，观察组CRRCAE各项评分高于对照组，提示强制诱导言语治疗与音乐疗法结合能显著提升脑卒中后失语症患者的各项语言能力，如听理解、复述、命名、出声读、阅读理解，还能更有效地提高患者的日常生活交流能力。与传统的言语治疗方法相比，这种联合疗法具有显著优势，包括更快的治疗效果、缩短治疗周期、增强治疗的趣味性和减少经济负担和心理压力。此外，该疗法能有效防止因疗程过长引发的疲惫感和信心丧失，避免训练中途停止的情况发生[19]。

总之，对于脑卒中后失语症患者，强制诱导言语治疗与音乐疗法相结合的方法简便易行，效果显著。通过取长补短、互补互助的方式，这两种方法能够帮助患者更好地康复，提高生活质量。因此，这种结合治疗方法值得在临床上广泛推广和应用。

参　考　文　献

[1] Johnston SC, Mendis S, Mathers CD. Global variation in strokeburden andmortality: estimatesfrom monitoring, surveillance, and modelling. Lancet Neurology, 2009, 8(4):345-354.

[2] Azar M, Askar G, Ali D, et al. Comparing the production of complex sentences in Persian patients with post-stroke aphasia and non-damaged people with normal speaking. Iranian Journal of Neurology, 2016, 15(1):28-33.

[3] 谢瑛，刘惠林，吴春薇，等. 强制性诱导语言治疗对脑卒中后慢性失语症的效果观察. 中国康复理论与实践，2014, 20(11):1011-1013.

[4] 全国第四届脑血管病学术会议. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准. 中华神经科杂志，1996, 29(6):381-383.

[5] 陈立典，林秀瑶，陶静. 脑卒中中医康复单元中失语症患者的康复疗效观察. 中国康复医学杂志，2008, 23(2):161-162.

[6] 李胜利. 语言治疗学. 北京：人民卫生出版社，2008:76.

[7] 高素荣. 失语症. 北京：北京大学医学出版社，2006:516-518.

[8] Pulvermüller F, Neininger B, Elbert T, et al. Constraint-inducedtherapy of chronic aphasia after stroke. Stroke, 2001, 32(7):1621-1626.

[9] Taub E, Uswatte G, Bowman MH, et al. constraint-inducedtherapy combined with conventional neurorehabilitation techniques in chronic stroke patients with plegic hands: A case series. Arch Phys Med Rehabil, 2013, 94(1):86-94.

[10] Taub E, Uswatte G, Pidikiti R. Constraint-Induced Movement Therapy: a new family of techniques with broad application tophysical rehabilitation-a clinical review. J Rehabil Res Dev, 1999,

中国知网　https://www.cnki.net

36(3):237-251.
[11] 武惠香，丘卫红，康庄，等. 强制诱导语言治疗对慢性运动性失语患者语言恢复及脑功能重组的影响. 中国物理医学与康复杂志，2018, 40(7):503-508.
[12] 林雪华. 强制性诱导语言疗法在脑卒中运动性失语患者中的应用. 健康研究，2017, 37(3):332-333.
[13] Pulvermuller F, Hauk O, Zohsel K, et al. Therapy-related reorganization of language in both hemispheres of patients with chronic aphasia. Neuroimage, 2005, 28(2):481-489.
[14] 王婷，杨海芳. 综合音乐疗法结合语言训练治疗脑卒中后失语症 1 例. 新中医，2016, 48(8):270-271.
[15] 钱红，郝又国. 音乐疗法结合言语训练在脑卒中失语症康复中的应用研究. 中国康复，2016, 31(5):349-351.
[16] 朱晓菊，何小俊. 音乐疗法治疗脑卒中失语症的研究进展. 护理研究，2020, 34(2):288-290.
[17] 黄荷. 重复经颅磁刺激结合音乐疗法治疗失语症的应用进展. 世界最新医学信息文摘，2018, 18(9):125-126.
[18] 翁瑛丽，王秋晨，等. 强制诱导言语治疗对脑卒中后失语症康复效果的 meta 分析. 中国康复医学杂志，2019, 34(11):1346-1350.
[19] 赵亚军，陈长香，胖红雯，等. 强制诱导性语言对亚急性期脑卒中失语症患者语言功能的疗效. 中国康复理论与实践，2014, 20(7):656-658.

［收稿日期：2024-09-18］

正念减压联合耳部按摩对自然分娩初产妇分娩方式、产程及妊娠结局的影响分析

汪红梅

【摘要】 **目的**　分析正念减压联合耳部按摩对自然分娩初产妇分娩方式、产程及妊娠结局的影响。**方法**　选择 100 例自然分娩初产妇，以随机数表法分为对照组和观察组，各 50 例。对照组行常规干预，观察组行正念减压联合耳部按摩。比较两组不同产程疼痛评分、心理弹性评分、分娩结局及产程时间。**结果**　观察组第一产程、第二产程及第三产程疼痛评分分别为 (5.52 ± 1.46)、(4.17 ± 0.52)、(2.88 ± 0.66) 分，均低于对照组的 (7.40 ± 1.43)、(6.58 ± 0.81)、(4.22 ± 0.83) 分 (P<0.05)。干预前，两组心理弹性评分比较无统计学差异 (P>0.05)；干预后，观察组心理弹性评分 (84.55 ± 5.56) 分比对照组的 (71.34 ± 3.18) 分更高 (P<0.05)。观察组胎儿窘迫、新生儿窒息、产后出血发生率分别为 0、0、2.00%，均比对照组的 14.00%、12.00%、14.00% 更低 (P<0.05)。观察组第一产程、第二产程及第三产程时间分别为 (315.46 ± 51.15)、(45.68 ± 8.46)、(13.25 ± 3.02)min，均比对照组的 (380.25 ± 42.64)、(87.62 ± 10.81)、(22.81 ± 3.42)min 更短 (P<0.05)。**结论**　正念减压联合耳部按摩在自然分娩初产妇中应用效果较好，可改善产妇心理弹性，降低分娩疼痛程度，进而缩短产程，具有应用价值。

【关键词】 正念减压；耳部按摩；自然分娩；初产妇；分娩方式；妊娠结局
DOI：10.14163/j.cnki.11-5547/r.2025.04.046

Analysis of the effects of mindfulness-based decompression combined with ear massage on mode of delivery, duration of labor and pregnancy outcome of primipara in natural delivery

WANG Hong-mei. Tai'an Hospital of Traditional Chinese Medicine, Tai 'an 271000, China

【**Abstract**】 **Objective**　To analyze the effects of mindfulness-based decompression combined with ear massage on mode of delivery, duration of labor and pregnancy outcome of primipara in natural delivery. **Methods** 100 primipara in natural delivery were selected and divided into a control group and an observation group by random number table, each with 50 cases. The control group received routine intervention, and the observation group received mindfulness-based decompression combined with ear massage. The pain score in different stages of labor, psychological resilience score, labor outcome and duration of labor of the two groups were compared. **Results**　The pain scores in the first, second and third stages of labor in the observation group were (5.52 ± 1.46), (4.17 ± 0.52) and (2.88 ± 0.66) points, which were lower than (7.40 ± 1.43), (6.58 ± 0.81) and (4.22 ± 0.83) points in the control group (P<0.05). Before intervention, there was no significant difference in psychological resilience scores between the two groups (P>0.05). After intervention, the psychological resilience score of (84.55 ± 5.56) points in the observation group was higher than (71.34 ± 3.18) points in the control group (P<0.05). The

作者单位：271000　泰安市中医医院

中国知网　https://www.cnki.net